

15^e DUOS Jaarsymposium

DR. MARTEN DOOPER | WETENSCHAPSJOURNALIST

Op 12 december jl. stroomde de Steylzaal van het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg vol met mensen die de urologische oncologie op enigerlei wijze een warm hart toedragen. Het was weer tijd voor het DUOS Jaarsymposium, de vijftiende editie inmiddels. Dit derde lustrum omvatte onder andere voordrachten over de positie van de PARP-remmers bij prostaatkanker, nieuwe inzichten in de moleculaire subtypen van blaascarcinoom en (de beoogde doelen van) georganiseerde PSA-screening.

Aan medisch oncoloog dr. David Olmos (Madrid, Spanje) de eer dit jaar het spits af te bijten. Dat doet hij met een voordracht over de plaatsbepaling van PARP-remmers (eventueel in combinatie met androgeenreceptor-pathwayremmers; ARPI) in de behandeling van gemetastaseerd, hormoonongevoelig prostaatcarcinoom (mCRPC). De rationale voor het gebruik van PARP-remmers is, zoals bekend, dat het eiwit poly-ADP-ribose-polymerase (PARP) cruciaal is voor een van de twee systemen die cellen hebben om schade aan het DNA te repareren. Cellen waarin het andere DNA-reparatiesysteem, de homologe recombinatie, deficiënt is, zijn geheel afhankelijk van PARP. Dat systeem voor homologe recombinatie bestaat uit de eiwitten BRCA1, BRCA2, ATM, BRIP1, BARD1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCA, PALB2, PPP2R2A, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L. Een mutatie in één (of meer) van deze genen (HRD-tumoren) maakt de cel dus gevoelig voor PARP-remming. Dit is in 20-25% van de prostaat-tumoren het geval. Met name tumorcellen met een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen zijn gevoelig voor PARP-remmers. De positieve uitkomsten van de PROfound-studie hebben geleid tot goedkeuring van olaparib (na voorbehandeling met een ARPI) bij patiënten met BRCA1/2-gemuteerd mCRPC.¹

Het feit dat patiënten met BRCA1/2-gemuteerd mCRPC doorgaans maar kortdurend responderen op standaardtherapie (taxanen, ARPI) betekent wat Olmos betreft dat deze patiënten zo snel als het label het toelaat met olaparib behandeld moeten worden.² Voor patiënten met een andere vorm van HRD (mutatie in een van de andere genen voor HR-eiwitten) ziet

“Voor patiënten met BRCA1/2-gemuteerd mCRPC is een combinatie van een PARP-remmer en een ARPI als eerste- of tweedelijnsbehandeling aan te bevelen”

DAVID OLMOS

hij op grond van de uitkomsten van PROfound pas plaats voor olaparib-monotherapie als er geen andere optie (meer) is. Bij patiënten zonder HRD heeft monotherapie met olaparib geen meerwaarde.

Nadat in preklinische studies was vastgesteld dat PARP-remmers en ARPI mogelijk synergetisch werken, zijn er klinische studies uitgevoerd waarin deze combinaties zijn getest als eerstelijnsbehandeling bij mCRPC. Op basis van de uitkomsten van met name de PROpel- (olaparib + abirateron), TALAPRO-2- (talazo-

parib + enzalutamide) en MAGNITUDE-studie (niraparib + abirateron) concludeert Olmos dat een dergelijke combinatie voor patiënten met BRCA1/2-gemuteerd mCRPC als eerste- of tweedelijnsbehandeling is aan te bevelen.³⁻⁵ Ook voor patiënten met een ‘BRCA-like HRD’-profiel (een mutatie in PALB2, RAD51B, RAD51C, FANCA, RAD54L of CDK12) weegt de overlevingswinst van de combinatie van een PARP-remmer en ARPI in de eerste of tweede lijn op tegen de extra toxiciteit ervan, stelt Olmos. Voor patiënten met een ‘non BRCA-like HRD’-profiel (zoals tumoren met een ATM-mutatie) of ‘geen HRD’-profiel is dit niet het geval.

De EMA heeft de combinatie talazoparib plus enzalutamide geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met mCRPC bij wie chemotherapie niet geïndiceerd is. De NVMO-Commissie BOM heeft een positief advies hierover gegeven en de behandeling is vanaf 1 december 2025 beschikbaar en vergoed in Nederland.⁶

Perioperatief of alleen neoadjuvant?

Vervolgens bespreekt urologisch chirurg dr. Bernadett Szabados (Londen, Verenigd Koninkrijk) de recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van spierinvasief blaascarcinoom (MIBC). De standaardbehandeling daarbij is tegenwoordig perioperatieve systemische therapie. Bij patiënten die cispla-



Stichting DUOS
Dutch Uro-Oncology
Studygroup

tine aankunnen bestaat het neoadjuvante deel daarvan in principe uit vier kuren durvalumab plus gemcitabine/cisplatine en het adjuvante deel uit acht kuren durvalumab, in navolging van de NIAGARA-studie.⁷ Bij patiënten die geen cisplatine aankunnen zou de behandeling bij voorkeur moeten bestaan uit neoadjuvant drie kuren enfortumab vedotin (EV) en pembrolizumab en adjuvant zes kuren EV en veertien kuren pembrolizumab, in navolging van de KEYNOTE-905-studie.⁸ Deze behandeling is echter nog niet beschikbaar in Nederland noch in Groot-Brittannië.

“Een pCR is niet voldoende om af te zien van adjuvante therapie bij spierinvasief blaaskanker”

BERNADETT SZABADOS

De hamvraag voor beide behandelingen is momenteel in hoeverre het adjuvante deel van de behandeling nog toegevoegde waarde heeft, stelt Szabados. De uitkomsten van twee kleine fase 2-studies zetten in ieder geval vraagtekens bij de adjuvante toediening van durvalumab in de NIAGARA-studie. In deze studie werden met alleen een neoadjuvante behandeling (respectievelijk atezolizumab/gemcitabine/cisplatine en pembrolizumab/gemcitabine/cisplatine) vergelijkbare uitkom-

sten behaald wat betreft percentage pathologisch complete respons (pCR), eventvrije overleving na één jaar en algehele overleving na één jaar.^{9,10}

“In de praktijk heeft een deel van de patiënten voldoende aan de neoadjuvante behandeling, verbetert de adjuvante behandeling bij een klein deel van de patiënten de overleving en heeft een ander deel van de patiënten geen baat bij de adjuvante behandeling. De vraag is nu: hoe herkennen we de patiënten die baat hebben van de adjuvante therapie?”

Het behalen van een pCR is in ieder geval niet voldoende om af te zien van adjuvante therapie, liet Szabados zien aan de hand van de uitkomsten van de NIAGARA-studie. Ook patiënten met een pCR profiteerden van durvalumab. Circulerend tumor-DNA (ctDNA) is mogelijk een goede kandidaat om patiënten te selecteren voor een adjuvante behandeling. In de IMvigor011-studie was de overleving van patiënten die een jaar lang na de radicale cystectomie geen aantoonbaar ctDNA hadden (en daarom geen aanvullende behandeling kregen) zeer goed: 88,4% ziektevrije overleving en 97,1% algehele overleving twee jaar na de cystectomie. Bij patiënten met aantoonbaar ctDNA verbeterde de adjuvante behandeling met atezolizumab de overleving.¹¹ De nog lopende MODERN-studie onderzoekt verder hoe de ctDNA-status kan worden gebruikt om de behandeling van MIBC verder te personaliseren.¹²



David Olmos

DUOS JAARSYMPOSIUM 2025



Szabados rondt haar voordracht af met de inschatting dat het behandelarsenaal voor MIBC de komende tijd met tal van andere antilichaam-geneesmiddelconjugaten zal worden uitgebreid.

Samenwerken bij prostaatkanker

Onder het motto *Collaboration is the key* gaat nucleair geneeskundige prof. dr. Daniela Oprea-Lager (Radboudumc, Nijmegen) in haar voordracht in op het belang van samenwerking bij prostaatkanker. Daarmee bedoelt ze niet alleen de samenwerking tussen de vele disciplines die tegenwoordig bij de behandeling van prostaatkanker zijn betrokken. Met de komst van de ¹⁷⁷Lu-PSMA-behandeling zijn nu ook de nucleair geneeskundigen behandelbaar geworden. Nee, zij doelt vooral op het belang van samenwerking tussen de verschillende behandelmodaliteiten. Meer specifiek gaat zij daarbij in op de ontwikkelingen rondom ¹⁷⁷Lu-PSMA in combinatie met radio- en/of hormoontherapie (ADT) en/of ARPI's.

¹⁷⁷Lu-PSMA is vooralsnog alleen goedgekeurd als behandeling (in derde of latere lijn) bij

Neem de behandeling van oligometastasen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat gericht behandelen (met radiotherapie) van oligometastasen de behandeling met ADT kan uitstellen, wat de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede komt. De BULLSEYE-studie toonde aan dat ook ¹⁷⁷Lu-PSMA bij patiënten met oligometastasen de tijd tot ADT uitstelt.¹⁴ Inmiddels lopen er wereldwijd diverse klinische studies die ¹⁷⁷Lu-PSMA bij patiënten met oligometastasen combineren met radio- en/of hormoontherapie. “De uitkomsten van deze studies gaan antwoord geven op de vraag of deze combinatietherapieën inderdaad leiden tot een betere tumorcontrole en dus uitstel van ADT en, zo ja, hoe deze combinaties het beste kunnen worden uitgevoerd. Wanneer geef je ¹⁷⁷Lu-PSMA, wanneer en hoe vaak bestraal je en/of geef je hormoontherapie en met welke doses?” Recent gepubliceerde uitkomsten van de fase 2-LUNAR-studie laten zien dat twee giften ¹⁷⁷Lu-PSMA voorafgaand aan bestraling zowel de progressievrije overleving als de tijd tot ADT verbetert.¹⁵ “Echter, na een follow-up van 22 maanden vertoont 64% van de patiënten in de combinatiearm progressie. We zijn er dus nog lang niet”, tempert Oprea-Lager de feestvreugde.

Ook voor de patiënten die reeds in aanmerking kunnen komen voor een behandeling met ¹⁷⁷Lu-PSMA biedt combinatietherapie mogelijk een verbetering, laat Oprea-Lager zien. In de fase 3-PSMAddition-studie verbeterde het toevoegen van ADT en ARPI aan ¹⁷⁷Lu-PSMA de (radiografische) progressievrije overleving met 28%.¹⁶ “De algehele overleving verbeterde (nog) niet door het toevoegen van ADT en ARPI aan ¹⁷⁷Lu-PSMA.”

Oprea-Lager sluit af met de combinatie van ¹⁷⁷Lu-PSMA met radicale prostatectomie bij gelokaliseerd hoog-risicoprostaatkanker, dus helemaal aan het begin van de ziektegeschiedenis. “Deze fase 1/2-LuTectomy-studie (n=20) laat zien dat neoadjuvant toedienen van ¹⁷⁷Lu-PSMA veilig is.¹⁷ Wel is de geabsorbeerde radioactieve dosis in zowel de klieren als de

prostaat erg hoog. Dat maakt nieuwsgierig naar eventuele late toxiciteit.”

De rol van fibroblasten bij NMIBC

Hierna wijdt uroloog dr. Tahlita Zuiverloon (Erasmus MC, Rotterdam) de aanwezigen in in de moleculaire finesses van niet-spierinvasief blaaskanker (NMIBC) en het belang daarvan voor de overgang naar MIBC. De hoeksteen van de behandeling van hoog-risico-NMIBC is het opwekken van een immuunrespons in de blaas met BCG. “Nadelen daarvan zijn dat slechts de helft van de patiënten er baat bij heeft, de behandeling behoorlijk toxisch is én er regelmatig een tekort is aan BCG”, somt Zuiverloon de uitdagingen daarbij op. Dit alles maakt dat zij onderzoekt hoe patiënten met hoog-risico-NMIBC beter zijn te stratificeren, zodat alleen de patiënten die er baat bij hebben een BCG-behandeling krijgen aange-

boden. En dat er gericht gezocht kan worden naar nieuwe therapieën voor de patiënten die niet op BCG reageren.

Zuiverloon laat zien dat hoog-risico-NMIBC aan de hand van het RNA-expressiepatroon te verdelen is in drie moleculaire subtypen: BRS1, BRS2 en BRS3.¹⁸ “Daarbij zijn BRS3-tumoren de tumoren die ongevoelig zijn voor BCG en die snel evolueren tot MIBC.” Verder inzoomend op de BRS3-tumoren zag Zuiverloon dat deze tumoren amper urotheelcellen bevatten. Ze bestaan voornamelijk uit stroma en regulatoire T-cellen, het type T-cellen dat de door BCG opgewekte immuunrespons onderdrukt. Door vervolgens de verschillende subtypen BRS-tumoren in kweek te brengen, kon Zuiverloon aantonen dat de fibroblasten in het stroma van de BRS3-tumoren onmisbaar zijn voor het in stand houden van het BRS3-profiel van de tumor. “Deze fibroblasten zijn wolven in

“ Deze fibroblasten in het stroma van de BRS3-tumoren zijn wolven in schaapskieren ”

TAHLITA ZUIVERLOON

schaapskieren”, stelt ze. “Ze geven signaalstoffen aan de urotheelcellen, die in kleine hoeveelheden in de buitenrand van de BRS3-tumor aanwezig zijn. Deze signaalstoffen zetten de urotheelcellen aan tot de productie van diverse heat-shockeiwitten, die op hun beurt lokaal de immuunrespons onderdrukken. Dit laatste maakt de BRS3-tumor ongrijpbaar voor het immuunsysteem, waardoor de tumor kan uitgroeien tot MIBC”, schetst Zuiverloon de opeenvolgende stappen. Nieuwe therapieën om NMIBC met een BRS3-profiel te behandelen zouden zich dan ook moeten richten op de fibroblasten en niet alleen op de urotheelcellen of het immuunsysteem, vindt zij.

Fred Guurink Prijs

Vast onderdeel van het DUOS Jaarsymposium is sinds 2019 de uitreiking van de Fred Guurink Prijs voor het beste uro-oncologische proefschrift in het afgelopen jaar. Dit jaar valt dr.

“ Leidt combineren van ¹⁷⁷Lu-PSMA met radio- en/of hormoontherapie tot een betere tumorcontrole en dus uitstel van ADT? ”

DANIELA OPREA-LAGER

mCRPC. “In diverse studies wordt nu onderzocht of het effect van deze behandeling is te verbeteren door die te combineren met andere vormen van therapie. Het idee hierbij is dat bijvoorbeeld een combinatie van radiotherapie en ¹⁷⁷Lu-PSMA synergistisch kan werken en tevens micrometastasen aanpakt die op de PSMA-PET/CT-scan nog niet zichtbaar zijn. Mogelijk kan daardoor de biologische controle toenemen, zelfs met een lagere dosis straling op het kleine bekken. Dat laatste zou de toxiciteit van de behandeling kunnen verminderen.”¹³

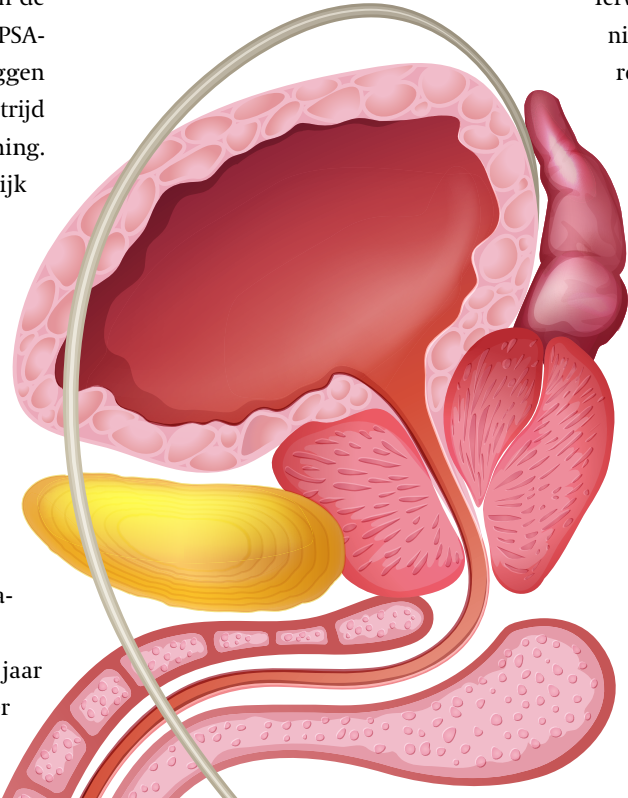
DUOS JAARSYMPOSIUM 2025

Jeroen van Dorp deze eer ten deel voor het proefschrift ‘*On preoperative systemic treatment of muscle-invasive bladder cancer*’, waarop hij in januari 2025 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Bij afwezigheid van de familie van Fred Guurink overhandigt prof. dr. Ronald de Wit dit jaar de prijs.

PSA-screening: waarom wel/niet?

Als afsluitende spreker duikt uroloog dr. Roderick van den Bergh (Erasmus MC) in de voor- en nadelen van georganiseerde PSA-screening. Daarbij begint hij met te zeggen dat het wat hem betreft niet gaat om een strijd tussen voor- en nadelen van PSA-screening. “We moeten kijken hoe we zoveel mogelijk van de voordelen kunnen profiteren en tegelijk daarbij de nadelen zo beperkt mogelijk houden.” Hij vergelijkt PSA-screening met wapenregulering. “In de handen van sommigen kunnen deze nuttig zijn voor de samenleving, maar als het bezit ervan niet wordt gereguleerd, gaat het mis; zie de Verenigde Staten.” Kernboodschap van zijn betoog is dan ook dat in de huidige situatie – met veel opportunistische PSA-screening – de nadelen de voordelen overschaduwden. Die voordelen zijn de afgelopen dertig jaar aangetoond in diverse studies, waaronder de Nederlandse ERSPC-studie: regelmatige PSA-screening kan de sterfte

aan prostaatkanker verminderen.¹⁹ Van den Bergh: “De afname van de sterfte varieert daarbij sterk tussen de studies en is afhankelijk van tal van factoren: start- en stopleeftijd, screeningsinterval, afkapwaarde, overige kenmerken van deelnemers. En niet te vergeten de mate van opportunistische PSA-screening in de controlegroep.” Met name dat laatste heeft in veel (westerse) landen een hoge vlucht genomen en vertroebelt



(foto: © Freepik.com)

volgens Van den Bergh de discussie over het nut van PSA-screening. “Opportunistische screening vindt – mede onder invloed van ‘gekleurde berichtgeving’ in de media en verschil in *awareness* – vooral plaats onder oudere, hoogopgeleide mannen zonder extra risicofactoren. In deze populatie tikken vooral de nadelen van PSA-screening zoals overdiagnostiek, bijwerkingen van diagnostiek en onnodig beslag op mensen en middelen als MRI, flink aan. Terwijl juist bij de populatie waarin PSA-screening het meeste voordeel kan opleveren – relatief jonge mannen met een positieve familiegeschiedenis – amper PSA-screening plaatsvindt.”

“In de oudere populatie tikken vooral de nadelen van PSA-screening aan”

RODERICK VAN DEN BERGH

Van den Bergh pleit daarom voor het opzetten van een georganiseerde PSA-screening die rekening houdt met de voorafkansen van de deelnemers op het krijgen van (een agressieve vorm van) prostaatkanker. Daarbij is het ook nodig dat beleidsmakers en zorgverleners zorgen voor goede, uniforme informatie over voor- en nadelen van PSA-screening en dat deze

informatie bij alle doelgroepen aankomt en begrepen wordt. “Vervolgens moeten we aan de hand van implementatiestudies uitzoeken hoe we de screening zodanig kunnen organiseren dat de ziektelast van prostaatkanker afneemt, het opportunistisch screenen van PSA wordt beperkt en de mensen en middelen worden ingezet bij de mannen die er het meeste voordeel van hebben.” ■

REFERENTIES

1. Hussain M, et al. N Engl J Med 2020;383:2345-57.
2. Olmos D, et al. Ann Oncol 2024;35:458-72.
3. Saad F, et al. Lancet Oncol 2023;24:1094-108.
4. Agarwal N, et al. Lancet 2023;402:291-303.
5. Chi KN, et al. Eur Urol Oncol 2025;8:986-98.
6. NVMO CieBOM. Med Oncologie 2024;27:17.
7. Powles TB, et al. N Engl J Med 2024;391:1773-86.
8. Vulsteke D, et al. Ann Oncol 2025;36 (suppl 2):S1763.
9. Funt SA, et al. J Clin Oncol 2022;40:1312-22.
10. Rose TL, et al. J Clin Oncol 2021;39:3140-8.
11. Powles TB, et al. N Engl J Med 2025;393:2395-408.
12. MODERN-studie. Te raadplegen via clinicaltrials.gov/study/NCT05987241#study-overview
13. Teunissen FR, et al. J Nucl Med 2025;66:1852-8.
14. Privé BM, et al. J Clin Oncol 2025;43:5009.
15. Kishar AU, et al. J Clin Oncol 2025;43:3812-21.
16. Tagawa ST, et al. Ann Oncol 2025;36 (Suppl 2):S1742-3.
17. Eapen RS, et al. Eur Urol 2024;85:217-26.
18. De Jong FC, et al. Sci Transl Med 2023;15:697.
19. Roobol MJ, et al. N Engl J Med 2025;393:1669-80.